

Síndrome nefrótica · edema e proteinúria

Nefrótico = proteinúria maciça + hipoalbuminemia + edema ($\pm$ hiperlipidemia). Trate edema e impeça complicações; a biópsia define etiologia no adulto.

Causas por faixa

Dica - Causas por faixa

Criança: lesões mínimas. Adulto: membranosa, FSGS, amiloidose, diabetes. Sempre rastrear HBV/HCV/HIV, LES e neoplasias quando indicado.

Fórmula mental de prova: $>3,5$ g/dia + albumina baixa + edema; lipidemia e lipidúria completam o quadro.

Critérios de síndrome nefrótica

Proteinúria + hipoalbuminemia + edema

Prot $>3,5$ g/dia + Alb baixa + edema

Adulto: biópsia costuma guiar; criança: LESOES MINIMAS empiricas em cenário típico

Conduta de suporte

- Restrição salina + diurético de alça (cuidado com intravascular efetivo)
- IECA/BRA para reduzir proteinúria se função renal permitir
- Estatina conforme lipidemia; anticoagular se trombose ou risco muito alto (albuminúria grave)
- Vacinas e vigilância de infecção (peritonite espontânea em ascite nefrótica)

Nefrótico $\times$ nefrítico

Item | Nefrótico | Nefrítico

Proteinúria | Maciça ($>3,5$ g/dia) | Leve-moderada

Hematuria | Ausente/leve | Disforma + cilindros

HAS / IRA | Variável | Comuns

Edema | Intenso / anasarca | Presente, menos lipídico

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Risco trombótico (incluindo veia renal) é alto na membranosa e na hipoalbuminemia grave. Dor no flanco + hematúria/ piora de função !' pense trombose de veia renal.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Crítérios laboratoriais (proteinúria maciça e hipoalbuminemia) fecham a síndrome nefrótica e guiam complicações.

Proteinúria "e 3,5 g/dia + hipoalbuminemia (+ edema ± dislipidemia).

Critérios da síndrome nefrotica

Labs clássicos

- 1 Proteinuria $\geq 3,5$ g/24h
- 2 Hipoalbuminemia (tipicamente $< 3,0$ g/dL)
- 3 Edema
- 4 Hiperlipidemia / lipiduria (suporte)

Relação proteína/creatinina urinária pode substituir 24h

Criança: doença de lesões mínimas. Adulto: membranosa, FSGS, diabetes.

Causas por idade (ideia)

Associações de prova



Nefrótico vs nefrítico

| Nefrótico | Nefrítico

Proteinúria | "e 3,5 g/dia | leve-moderada

Albumina | !"" | normal/pouco !"

Hematúria | ausente/leve | ativa (disomorfa, cilindros)

HAS/IRA | menos marcantes | comuns

Edema | +++ | +/-

Complicações clássicas

- Trombose (perda de antitrombina; incluindo veia renal)
- Infecções (perda de Ig)
- Hiperlipidemia e risco aterosclerótico
- LRA pré-renal / hipovolemia intravascular com edema

Conduta inicial

Dica - Conduta inicial

Restrição salina, diurético, IECA/BRA, estatina se dislipidemia, anticoagular se trombose (e considerar se albumina muito baixa + membranosa). Biópsia no adulto na maioria dos casos.

Membranosa no adulto

Lembre - Membranosa no adulto

Anti-PLA2R ajuda etiologia primária; associar a câncer, HBV, lúpus, fármacos quando secundária.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1